

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА



ДИПЛОМСКИ ТРУД ПО ПРЕДМЕТОТ:

ОСНОВИ НА СПЕЦИЈАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИСКА ПЕДАГОГИЈА

НАСЛОВ:

**РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА АУТИЗМОТ КАЈ ДЕТЕ ОД ПРЕДУЧИЛИШНА
ВОЗРАСТ**

МЕНТОР

Проф. Д-р Марија Ристевска

КАНДИДАТ

Анастасија Грданова (6334)

Битола, 2026 година

Содржина

Вовед.....	4
1. Теоретски основи на аутизмот	5
1.1. Што е аутизам?	5
1.2. Историски развој на аутизмот	7
1.3. Аутистичен спектар на нарушување – видови синдроми.....	8
1.4. Причини и фактори на ризик за аутизмот.....	9
1.5. Современи класификации на аутизмот	10
2. Карактеристики на децата со аутизам	11
2.1. Социјална интеракција	11
2.2. Комуникациски карактеристики.....	12
2.3. Бихејвиорални и емоционални карактеристики	13
2.4. Сензорни особености кај децата со аутизам.....	13
3. Раното препознавање на аутизмот кај децата	14
3.1. Значење на раната детекција.....	14
3.2. Рани знаци кај децата со аутизам од предучилишна возраст	15
3.3. Улогата на родителите во препознавање на симптомите	16
3.4. Улогите на воспитувачите и стручните соработници.....	17
3.5. Скрининг и дијагностички инструменти	17
4. Интервенции и поддршка по раното препознавање	18
4.1. Рана интервенција.....	18
4.2. Мултидисциплинарен пристап во третманот на аутизмот	19
4.3. Семејна поддршка и советување	19
5. Истражувачки дел	20
5.1. Предмет на истражување	20
5.2. Цел на истражувањето.....	20
5.3. Хипотеза	20
5.4. Методологија	21
5.4.1. Метод на истражување.....	21

5.4.2.	Техники и инструменти	21
5.4.3.	Испитаници	21
5.4.4.	Примерок.....	21
5.4.5.	Постапка на истражувањето	21
5.5.	Општи податоци и развоен тек на детето	21
5.5.1.	Субјективен опис на однесувањето и развојот на детето од страна на мајката.....	22
5.5.2.	Субјективен опис на однесувањето и развојот на детето од страна на бабата	22
5.6.	Анализа на добиените податоци.....	23
5.6.1.	Анализа на интервју со мајката	23
5.6.2.	Анализа на интервју со бабата.....	24
5.6.3.	Анализа на интервју со дефектологот.....	24
5.6.4.	Анализа на интервју со логопедот	24
5.6.5.	Анализа на интервју со воспитувачката	24
5.6.6.	Анализа на стручна документација.....	25
5.7.	Прилози	26
5.8.	Дискусија.....	30
Заклучок.....		31
Користена литература.....		33

Вовед

Аутизмот претставува невроразвојно нарушување кое влијае врз комуникацијата, социјалната интеракција и однесувањето на детето. Нарушувањето од аутистичен спектар се јавува уште во раното детство и може да се забележи преку различни симптоми како што се избегнување контакт со очи, потешкотии во говорот, ограничена комуникација, повторувачки движења и намалена социјална интеракција. (Кировска, М. Развојни нарушувања кај деца)¹

Раното препознавање на симптомите е од особено значење бидејќи овозможува навремена интервенција и соодветна стручна поддршка. Колку порано се откријат првичните знаци, толку поголеми се можностите за подобрување на комуникацијата, однесувањето и социјалната адаптација на детето. Меѓутоа, симптомите на аутизмот се разликуваат од дете до дете, така што две деца со аутизам може да дејствуваат доста различно. Во најголемиот број случај, децата со аутизам имаат изразени тешкотии или потполна неможност за интеракција и комуникација. Децата со аутизам манифестираат тешкотии во три клучни подрачја во развојот, познати како „тријада во оштетувањето“ и тоа во социјалната интеракција, комуникација и однесувањето. (М.Ристевска, Инклузивна педагогија стр.43)²

Предучилишната возраст претставува клучен период за идентификација на првите симптоми на аутизмот. Во процесот на рано откривање особено значајна улога имаат родителите, воспитувачите, педијатрите, психолозите и специјалните едукатори и рехабилитатори. Преку внимателно следење на развојот на детето можат навремено да се забележат одредени отстапувања кои упатуваат на можност за постоење на аутистичен спектар на нарушувања.

Предмет на овој труд е раното препознавање на аутизмот кај деца од предучилишна возраст, со посебен акцент на раните симптоми, улогата на семејството и воспитно-образовните институции, како и значењето на раната интервенција за понатамошниот развој на детето. Целта на трудот е да се прикаже важноста на навременото препознавање на аутизмот и да се истакнат можностите за поддршка и интервенција кои придонесуваат за подобар квалитет на живот на детето и неговото семејство.

Посебна вредност на овој труд претставува истражувачкиот дел, кој преку квалитативна анализа овозможува согледување на процесот на рано препознавање на

¹ Кировска, М. Развојни нарушувања кај деца

² М.Ристевска, Инклузивна педагогија стр.43

аутизмот во реален контекст. Анализата е насочена кон следење на раните развојни индикатори, препознавањето на првите симптоми, улогата на семејството и стручните лица во процесот на идентификација, како и значењето на навременото реагирање по појавата на развојните отстапувања.

1. Теоретски основи на аутизмот

1.1. Што е аутизам?

Аутизмот претставува невроразвојно нарушување кое се карактеризира со потешкотии во социјалната комуникација и интеракција, како и со ограничени и повторувачки модели на однесување, интереси или активности. Денес најчесто се користи терминот „аутистичен спектар на нарушувања“ бидејќи симптомите можат да се јават во различни форми и степени на изразеност. Спектарот опфаќа широк опсег на индивидуални разлики, па затоа секое лице со аутизам има свои специфични карактеристики, способности и потреби. Лицата со аутизам можат да покажуваат различни тешкотии во воспоставувањето и одржувањето социјални односи. Кај некои лица се забележуваат потешкотии во разбирањето на невербалната комуникација, како што се мимиките, гестовите и контактот со очите, додека кај други може да биде присутна тешкотија во разбирањето на емоциите и намерите на другите луѓе. Воедно, може да постојат разлики во начинот на кој лицата со аутизам комуницираат, при што некои користат говор без значителни потешкотии, а други имаат ограничен или отсутен говор и се потпираат на алтернативни форми на комуникација. Една од главните карактеристики на аутистичниот спектар се ограничените и повторувачки модели на однесување. Тие можат да се манифестираат преку повторување на одредени движења, инсистирање на рутини и предвидливост во секојдневните активности, силна приврзаност кон специфични интереси или интензивна преокупација со одредени теми. Промените во вообичаената средина или во дневната рутина често можат да предизвикаат вознемиреност и непријатност кај некои лица со аутизам. Кај многу лица со аутизам се присутни и специфичности во сензорната обработка на информациите. Тие можат да бидат преосетливи или намалено чувствителни на различни стимули од околината, како што се звуци, светлина, допир, мириси или вкусови. На пример, одредени звуци кои за повеќето луѓе се вообичаени може да бидат исклучително непријатни или вознемирувачки за лице со аутизам. Од друга страна, некои лица можат да покажуваат намалена реакција на болка или други сетилни дразби. Аутизмот не е болест што може да се излекува, туку состојба која го следи лицето во текот на целиот живот. Сепак, со навремена поддршка, рана идентификација и соодветни интервенции може значително да се подобри функционирањето и квалитетот на животот на лицата со аутизам. Поддршката треба да биде индивидуализирана и прилагодена на потребите на секое лице, а може да вклучува логопедски третмани, едукативна поддршка, психолошко советување, окупациона терапија и развивање на социјални и комуникациски

вештини. (American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). Washington, DC.)³

Иако лицата со аутизам се соочуваат со различни предизвици, тие исто така можат да поседуваат значајни способности и силни страни. Кај некои лица се забележуваат исклучителни способности во области како што се меморијата, математиката, музиката, уметноста, технологијата или вниманието кон детали. Поради тоа, современиот пристап кон аутизмот се заснова не само на препознавање на потешкотиите, туку и на поддршка на потенцијалите, самостојноста и активното учество на лицата со аутизам во образованието, семејниот и општествениот живот. (Frith, U. (2003). Autism: Explaining the Enigma. Oxford: Blackwell Publishing)⁴

Како и да е, дефинициите на нарушувањето неизбежно водат до конфузија, затоа тука ќе бидат наведени неколку показатели кои треба да разјаснат што е тоа аутизам и што всушност не е.

Аутизмот претставува:

- Первазивно развојно нарушување кое ги вклучува биолошките или органските дефекти во функционирањето на мозокот;
- Кај машките се појавува четири пати повеќе отколку кај женските;
- Спектрално нарушување- опфаќајќи индивидуи со длабоки тешкотии во учењето во учењето кај луѓето со просечен или натпросечен IQ;
- Асоциран со познати органски причини, на пример: мајчинска рубела, туберозна склероза;
- Асоциран со епилепсија кај една третина од индивидуите во адолесценцијата;
- Во многу случаи генетски поврзан;
- Асоциран со необични одговори на сензорни стимулации

Аутизмот не е:

- Резултат на емоционална лишеност или емоционален стрес;
- Желба да се избегне социјален контакт;
- Резултат на родителско отфрлање или „ладни родилели“;
- Класно и расно поврзан;
- Ментално заболување (Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр20)⁵

³ American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). Washington, DC.

⁴ Frith, U. (2003). Autism: Explaining the Enigma. Oxford: Blackwell Publishing

⁵ Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр20

1.2. Историски развој на аутизмот

Во историјата може да се сретнат повеќе дефиниции за аутизмот во кои се открива неговата суштина, комплексноста на проблемот и хетерогеноста на клиничката слика.

Според Светската здравствена организација, детскиот аутизам претставува первазивно развојно нарушување кое се дефинира со постоење на ненормален или оштетен развој што се манифестира пред третата година од животот со карактеристичен облик на патолошко функционирање во сите три области на социјалните интеракции, во комуникациите и со повторувачко однесување.

Американската психијатриска асоцијација го дефинира аутизмот како широк континум на поврзани когнитивни и невробихевиорални нарушувања, вклучувајќи три карактеристики: нарушување во социјализацијата, нарушување во вербалната и невербалната комуникација и рестриктивни и репетитивни шеми на однесување.

Други научници на историјата велат дека аутизмот е тешка форма на група нарушувања, наречени первазивни развојни нарушувања (ПРН). ПРН се карактеризираат со растројства во социјалните и комуникативните вештини и со присуство на необични активности и интереси како што се: ритуали стереотипи и лоши игровни вештини. ПРН се појавуваат како невролошки нарушувања со мултипно потекло и може да се појават заедно со други развојни нарушувања. (Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр 18.)⁶

Терминот аутизам значи „битисување во себе“ и е востановен од швајцарскиот психијатар Eugen Bleuler во 1911 година, кој го опишува лошиот социјален контакт кај шизофренијата. Од друга страна зборот аутизам е изведен од старогрчкиот збор „autos“, за „сам“. Овие деца се карактеризирале со екстремна осаменост, лоши комуникации и отпор кон промени.(Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр19.)⁷

Во 1943 година детскиот психијатар Лео Канер објавил научен труд во кој опишал единаесет деца со специфични потешкотии во комуникацијата и социјалната интеракција. Тој ги истакнал карактеристиките како осаменост, отпор кон промени и ограничени интереси. Една година подоцна Ханс Аспергер опишал група деца кои покажувале слични карактеристики, но имале добро развиен говор и просечни или надпросечни интелектуални способности. Подоцна оваа состојба станала позната како Аспергеров синдром.(Attwood, T. (2007). The Complete Guide to Asperger's Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers)⁸

⁶ Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр 18

⁷ Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр19

⁸ Attwood, T. (2007). The Complete Guide to Asperger's Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers

Во текот на дваесеттиот век сфаќањата за аутизмот значително се менувале. Денес аутизмот се смета за невроразвојно нарушување со биолошка основа и се класифицира како аутистичен спектар на нарушувања.

1.3. Аутистичен спектар на нарушување – видови синдроми

Терминот аутистичен спектар означува широк опсег на карактеристики и потреби кај лицата со аутизам. Некои лица имаат значителни потешкотии во комуникацијата и секојдневното функционирање, додека други можат успешно да се образуваат, да работат и да живеат самостојно.

Спектарот ги опфаќа различните степени на изразеност на симптомите, нивното влијание врз секојдневниот живот и потребата од поддршка. Токму поради ова секое дете со аутизам треба индивидуално да се проценува и третира.

Во аутистичен спектар на нарушувања спаѓаат аутизмот познат како Канеров синдром, Аспергеров и дезинтегративно нарушување во детството познато како Ретов синдром и Хелеров синдром. Овие нарушувања можат да бидат придружувани со други нарушувања, како нарушувања во сензорната интеграција, депресија, биполарно нарушување, АДХД, дислексија, диспрахија, епилепсија и др. (М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр.40)⁹

За Аспергеровиот синдром се вели дека е блага форма на аутизам. Лицата со синдромот Аспергер имаат тешкотии со социјалната интеракција, им недостасува емпатија, не се во можност да ги разберат другите и подобро остваруваат релации со возрасните отколку со врсниците. Исто така, не ги разбираат невербалните пораки на другите, имаат потреба од рутина и покажуваат репетитивно однесување. Во групните игри, детето со Аспергер, себеси не се доживува како член на групата, не ги следи интересите на другите деца, туку само сопствените. Овие деца не покажуваат интерес за групни спортови и игри. (М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр. 46-47)¹⁰

Хелеровиот синдром е карактеристичен поради тоа што постои период на нормален развој на детето и потоа во рок од неколку месеци се губат сите стекнати способности. Наеднаш се јавува аутистично однесување проследено со следниве синдроми : се губат експресивните и рецептивните јазични вештини, се губи интересот за околината, се губат социјалните вештини и стекнатите вештини за грижата за себе, се губи контролата на дебелиот црево или мочниот меур, се појавуваат репетитивни движења. Играта се осиромашува и на крај потполно се губи. Ова се случува обично на возраст помеѓу третата и четвртата година, но генерално пред десеттата година.

Ретовиот синдром најчесто настанува кај девијчињата, во првите години, најчесто по период на нормален развој. Се карактеризира со губење на стекнатите способности

⁹ М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 40

¹⁰ М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр.46-47

како кај хелеровиот синдром. Карактеристичен знак е движењето на рацете, наречено „перење на рацете“ според тоа што ги ставаат рацете во уста или прават движења со нив како да перат, гмечат, цедат и ги преплетуваат прстите. Нарушен е сонот, тешко заспиваат и често се будат. Движењето станува несигурно и успорено. Рацете и нозете им се секогаш студени. Често забрзано дишат, голтаат воздух или го стопираат дишењето. Иако имаат добар апетит, обично се многу слаби. Често имаат епилептични напади, деформитет на стапалата и подоцна деформитет со ‘рбетот. Во подоцнежниот живот најчесто се во количка.

Ретовиот и Хелеровиот синдром припаѓаат во категоријата детско дезинтегративно нарушување и најдобро ги објаснува дефиницијата: децата со детско дезинтегративно нарушување мора да имаат нормален развој до возраст од две години, а потоа настапува регресија што ја зафаќа не само социјалната комуникација, туку и другите сфери, како што се грубата и фината моторика. (М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 49.)¹¹

1.4. Причини и фактори на ризик за аутизмот

Причините за појавата на аутизмот сè уште не се целосно разјаснети, но современите научни истражувања покажуваат дека станува збор за сложено невноразвојно нарушување кое настанува како резултат на интеракција помеѓу генетски и невноробиолошки фактори. Не постои единствена причина за појавата на аутизмот, туку повеќе фактори кои можат да придонесат за негов развој.

Генетските фактори имаат значајна улога во настанувањето на аутизмот. Истражувањата покажуваат дека постои поголема веројатност за појава на аутизам кај деца кои имаат членови на семејството со нарушување од аутистичниот спектар. Идентификувани се повеќе гени кои се поврзуваат со развојот на ова нарушување, но ниту еден ген самостојно не е одговорен за неговата појава. Покрај генетските фактори, важна улога имаат и невноробиолошките фактори кои се поврзани со развојот и функционирањето на мозокот. Одредени промени во структурата и функционирањето на нервниот систем можат да влијаат врз развојот на комуникацијата, социјалната интеракција и однесувањето.

Меѓу факторите на ризик се вбројуваат повозрасната возраст на родителите, одредени компликации за време на бременоста и породувањето, предвремено раѓање и ниска родилна тежина. Сепак, присуството на овие фактори не значи дека детето сигурно ќе развие аутизам, туку само дека ризикот може да биде зголемен.

Важно е да се нагласи дека научните истражувања не пронашле докази за поврзаност помеѓу вакцинацијата и појавата на аутизам. Денес е општоприфатено дека аутизмот е резултат на сложена интеракција на повеќе биолошки фактори кои влијаат врз раниот развој на мозокот.

¹¹ М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 49.

Ова сознание е од особено значење бидејќи придонесува за подобро разбирање на природата на аутизмот и за намалување на предрасудите и погрешните верувања поврзани со неговото настанување.

1.5. Современи класификации на аутизмот

Според современите дијагностички критериуми, аутизмот се карактеризира преку две основни области:

- дефицити во социјалната комуникација и интеракција;
- ограничени, повторувачки модели на однесување, интереси или активности.

Во современата клиничка практика, аутизмот се разгледува како дел од аутистичниот спектар, што значи дека симптомите можат да се манифестираат со различен интензитет и во различни комбинации кај секое лице. Поради широкиот спектар на карактеристики, не постојат две лица со аутизам кои покажуваат идентична клиничка слика.

Дефицитите во социјалната комуникација и интеракција можат да се манифестираат преку потешкотии во воспоставувањето и одржувањето социјални односи, намалена способност за разбирање на невербалните сигнали, ограничена употреба на гестови и изрази на лицето, како и потешкотии во споделувањето интереси, емоции и искуства со другите луѓе. Кај некои лица овие потешкотии се благи и се забележуваат само во сложени социјални ситуации, додека кај други можат значително да влијаат врз секојдневното функционирање. Втората дијагностичка област се однесува на ограничените и повторувачки модели на однесување и интереси. Тие можат да вклучуваат повторувачки движења на телото, инсистирање на строги рутини, отпор кон промени во секојдневните активности, како и интензивен интерес за одредени теми или активности. Често се присутни и специфичности во сензорната обработка, како преосетливост или намалена чувствителност на звуци, светлина, допир, мириси или други дразби од околината.

Најшироко прифатената современа класификација е содржана во Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), каде што претходно одделните дијагнози како аутистично нарушување, Аспергеров синдром и первазивно развојно нарушување неодредено поинаку се обединети под единствената дијагноза „нарушување од аутистичниот спектар“ (Autism Spectrum Disorder – ASD). Овој пристап овозможува попрецизно опишување на индивидуалните разлики и нивото на потребна поддршка. Современите класификации исто така предвидуваат процена на степенот на потребна поддршка кај лицата со аутизам. Во зависност од сериозноста на симптомите, се разликуваат нивоа на поддршка кои се движат од потреба за умерена помош до потреба за многу значителна поддршка во секојдневното функционирање. При поставувањето на дијагнозата се земаат предвид и придружните состојби, како интелектуална попреченост, јазични нарушувања, нарушување на вниманието и хиперактивност (ADHD), анксиозност и други развојни или психијатриски состојби.

Дијагностичките критериуми овозможуваат рано препознавање на симптомите и поставување точна дијагноза. Во современата практика се користат различни скрининг

инструменти и проценки кои помагаат во идентификацијата на децата со ризик за аутизам. Процесот на дијагностицирање обично вклучува мултидисциплинарен пристап, при што учествуваат психолози, психијатри, педијатри, логопеди и други стручни лица. Раната идентификација е од особено значење бидејќи овозможува навремено започнување на интервенции и поддршка, што може позитивно да влијае врз развојот на комуникациските, социјалните и адаптивните вештини.(Catherine Lord, Michael Rutter et al. (2020). *Autism Spectrum Disorder*. The Lancet.)¹²

2. Карактеристики на децата со аутизам

2.1. Социјална интеракција

Социјалните нарушувања кај децата со аутизам стануваат забележливи во најраното детство. Децата со аутизам покажуваат намалено внимание кон социални стимулуси, имаат намален или неприсутен контакт со очи и антиципаторни држења. Ретко покажуваат социално разбирање, ретко спонтано му пристапуваат на другиот и ретко имитираат и одговараат на емоции. Лицето со аутизам покажува однесување како другите луѓе да не постојат, има мал или неприсутен контакт со очите и не одговара кога му се зборува. На неговото лице нема експресија со исклучок при екстремно задоволство, лутина или стрес и не дава оговор на милување, односно ја оттргнува раката која го милува. Ако нешто му е потребно, грижливо со рацете може да тргне кон предметот, а може како здраво дете да реагира на грубата игра, но потоа тоа се враќа на повлеченото држење по страна и се чини дека живее во „свој сопствен свет“. Кога на неговиот пат ќе се најде некое друго лице, тоа минува покрај него како воопшто и да не го забележува. Детето со аутизам не реагира на туѓите чувства: радост, насмевка, тага или плачење. Неговото внимание не го привлекува предметот или случката кои го привлекуваат вниманието на лицата од околината. Тоа не ги имитира движењата и гестовите и не може да го предвиди следното случување. Своите потреби ги изразува со повлекување на раката на возрастниот и приведување кон предметот што го интересира. Ако воопшто ги забележува лицата околу себе, тогаш почесто им приоѓа на возрастните отколку на врсниците. Кај одредена група со полесни симптоми, детето прифаќа социјални приближувања, може да се сретне вкочанет поглед во другите луѓе и може да биде вклучено како пасивен дел од играта. Други тешкотии во однесувањето се: конфузија и страв во непознати околности, немирно, деструктивно и агресивно однесување, врескање во јавноста проследено со вознемиреност и гнев.

Најтежок облик на однесување е незаинтересираноста и индиферентноста кон другите луѓе, посебно кон другите деца, на кои некои лица со аутизам уживаат во физички контакт. Поголемиот број на деца покажуваат, на едноставно физичко ниво, поврзаност со возрастните кои добро ги познаваат, меѓутоа се индиферентни кон врсниците. Лицата со аутизам можат да имаат тешкотии при сфаќањето кога некој е непристоен, па дури и злонамерен. Доколку ги замолите да направат нешто за вас тие ќе се чувствуваат должни тоа да го исполнат, водејќи се според изреката "за тоа служат пријателите". Децата со аутизам честопати не можат да ја забележат разликата кога другарите се смеат и си подигнуваат со нив. Лесно потпаѓаат под влијание на другите

¹² Catherine Lord, Michael Rutter et al. (2020). *Autism Spectrum Disorder*. The Lancet.

од едноставна причина што не знаат како поинаку да се однесуваат во дадената ситуација.(Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр140-141)¹³

2.2. Комуникациски карактеристики

Комуникациските потешкотии можат да се манифестираат на различни начини. Оштетување на говорот е дефинирачка карактеристика кај аутизмот. Користењето на говорот варира: од целосно немање (во 20% од случаите) до многу добро ниво на говор. Вообичаените проблеми во говорот вклучуваат: повторување на зборови кои им се кажани (ехолалија), барање на работи со повторување на фрази кои асоцираат на акциите, на пример: „Дали сакаш чаша чај" наместо „јас сакам чаша чај". Имаат недостаток на сврзници во реченицата како: „во", „на", „бидејќи" „под", така што на пример, детето може да каже „Идам кола продавница", изостувајќи ги сврзниците. Тоа објаснува во повеќе детали од потребното, дава долги одговори на прашањата искажани како да се научени од книга. Како што варира говорот, така варира и разбирањето на говорот. Дури и во најлошите случаи повеќето луѓе со аутизам можат да разберат дел од говорот. Тешкотите се искажуваат во повеќе ситуации: кога предметот има повеќе од едно име, како што е сад (да се измие или јаде?), имаат конфузија во звучењето на зборовите. Литературната интерпретација може да претставува проблем, замислете да земете фраза како што е „врнеше мачки и кучиња" или „дали си го изгубил твојот јазик". Хуморот, посебно оној поврзан со вербална двосмисленост, може да претставува тешкотија за личностите со аутизам.

Има повеќе карактеристики поврзани со начинот на говор кои можат да бидат забележани кај лицата со аутизам, и тие вклучуваат:

- Проблеми со јачина на гласот – понекогаш е прегласно, но почесто е тивко
- Гласот може да звучи механички или монотонно
- Изговорот може да биде пренагласен

Говорот е само еден од многуте начини на кои луѓето комуницираат. Сите видови на гестикација придружени со говорот вклучуваат: суптилни придвижувања на очите, движења со дланките и рацете и промена на позите. Луѓето кои не се аутистични, но имаат нарушувања на пример во говорот се способни да применуваат останати начини на комуникација. Од друга страна луѓето со аутизам имаат основни пречки во комуникацијата кои не се задржуваат само на говорот. Оттука лицата со аутизам имаат помала веројатност да развијат дополнителни комуникациски способности, а пак оние со позначителни пречки, коишто нормално би научиле јазик со мануелни знаци никогаш нема да го употребуваат спонтано. Доколку до 6 години не се развијат одреден број на зборови, понатамошниот развој на говорот ќе биде сериозно ограничен. Генерално, изговорањето на јазикот може да изгледа добро развиено, со добро совладана синтакса и вокабулар, при што на формалните јазични тестови многу индивидуи можат да постигнат добри резултати во сфаќањето и разбирањето на

¹³ Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр140-141

самостојни зборови, но имаат намалени способности за декодирање на комплексни инструкции или концепти. (Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр142)¹⁴

2.3. Бихејвиорални и емоционални карактеристики

Бихејвиоралните карактеристики се едни од главните обележја на аутистичниот спектар и се манифестираат различно кај секое лице. Најчесто вклучуваат повторувачки однесувања, како мафтање со рацете, нишање на телото или повторување на одредени зборови и активности. Лицата со аутизам често покажуваат потреба од рутина и предвидливост, при што промените во секојдневните активности можат да предизвикаат вознемиреност. Исто така, карактеристични се ограничени, но интензивни интереси кон одредени теми или активности. Кај многу лица се присутни и специфични реакции на сензорни дразби, како преосетливост или намалена чувствителност на звуци, светлина, допир и други надворешни стимули. Овие бихејвиорални карактеристики претставуваат дел од начинот на кој лицата со аутизам ја перципираат и обработуваат околината.

Емоциите кај лицата со аутизам долго време биле погрешно проценувани. Всушност, се зборувало за недостаток на емоции, при што се испуштил еден многу важен факт, дека детето длабоко во себе се вознемирува во оној момент кога во негова близина се наоѓа личноста за која тоа е приврзано или личноста која му е одбивна.

За децата со аутизам е карактеристично:

- Отсуство на мимика-знак дека детето се повлекува во себе
- Силни напади на страв и агресија
- Длабока тага коа се гледа во бесцелно заталканиот поглед на детето
- Некомуникативна радост која доаѓа сама по себе и се манифестира со потскокнување, треперење на рацете и еуфорија. Причината и значенето на таа радост јазнае самото дете.

Овие елементи наведуваат дека емоциите заостанале во развојот, односно останале на инфантилно и примитивно ниво, не наоѓајќи го понатамошниот пат за својот развој. (Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр155)¹⁵

2.4. Сензорни особености кај децата со аутизам

Кај децата и возрасните со аутизам, како и сите оние со развојни нарушувања, се јавува дисфункционалност на сензорниот систем. Понекогаш едно или повеќе сетилата

¹⁴ Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр142

¹⁵ Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр155

се пречувствителни или пак воопшто не се чувствителни на стимулации. Ваквиот сензорен проблем може да биде значајна причина за појава на однесување како што е нишање, вртење и треперење на рацете. Рецепторите за сетилата се сместени во периферниот нервен систем и се верува дека причината за проблемот лежи во невролошката дисфункција на мозокот. Мозокот ги лоцира, распоредува и интегрира дразбите кои доаѓаат од сетилата во целина, а кога тие доаѓаат на добро интегриран начин, можат да се употребат за формирање на перцепции, однесување или учење. Овој процес на организација на чувствата се нарекува сензорна интеграција. Таа започнува уште во матката на мајката кога детето ги чувствува движењата на мајката. Секое дете има вродена способност за сензорна интеграција која понатаму се развива низ интеракција со околината преку адаптирање на своето тело и мозок во дадени ситуации. Сензорната интеграција се јавува кога детето спонтано планира и успешно изведува адаптивна реакција на зададен инпут. Адаптивната реакција е целисходен, целно насочен одговор на сетилното доживување. Кај адаптивната реакција детето ја совладува тежината и учи нешто ново. Децата со аутизам покажуваат голем број на симптоми на слаба сензорна интеграција, но и дополнителни потешкотии во сензомоториката и другите подрачја. Поради тоа, нивната интеракција со околината е слаба, детето не е способно да регистрира голем број на сетилни дразби од околината, па така не може да ги интегрира и не може да формира јасна перцепција за просторот и својата положба во него.

Нарушувањето на сензорната обработка кај децата со аутизам има три аспекти. Првиот се однесува на неправилно регистрирање на сензорниот инпут во мозокот на детето. Поради тоа детето посветува многу малку внимание на повеќето нешта или во некои ситуации реагира премногу. Како второ, детето можеби не го модулира добро сензорниот инпут, посебно вестибуларните и тактилните дразби, па може да манифестира гравитациска несигурност или тактилна одбрана. Третиот аспект се однесува на дисфункција на делот на мозокот кој е одговорен за детето нешто да направи, па тоа покажува мал интерес или не покажува интерес да направи нешто целисходно и конструктивно. (Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр 150-151)¹⁶

3. Раното препознавање на аутизмот кај децата

3.1. Значење на раната детекција

Раното препознавање на аутизмот претставува еден од најважните фактори за успешен развој и напредок на детето. Во последните години научните истражувања укажуваат дека првите симптоми можат да се забележат уште во текот на првите две години од животот. Навременото препознавање овозможува рана интервенција, која придонесува за подобрување на комуникацијата, социјалните вештини, когнитивниот развој и адаптацијата на детето. Првите години од животот се период кога мозокот покажува најголема способност за учење. Токму затоа интервенциите започнати во рана возраст имаат значително поголем ефект во споредба со оние кои започнуваат подоцна. Доколку симптомите не бидат препознаени навреме, може да дојде до продлабочување на потешкотиите и намалување на можностите за напредок. Раната

¹⁶ Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр 150-151

детекција не значи поставување дијагноза веднаш по забележувањето на симптомите, туку претставува процес на идентификување на ризични показатели кои бараат дополнителна проценка од стручни лица. (Jordan, R. (2008). Autism Spectrum Disorders: A Guide for Educators. London.)¹⁷

3.2. Рани знаци кај децата со аутизам од предучилишна возраст

Првичните знаци кои укажуваат на аутизам се: доколку детето не се смее и не покажува знаци на среќа до шестиот месец животот, детето не реагира на звуци до девет месеци, не гуга до дванаесет месеци, не сака да се милува и да седи во прегратката на мајката, не покажува гестови или да покажува со прсте на предмети до дванаесет месеци, воопшто не зборува до дванаесет месеци, не изговара никакви фрази до две години, ги губи стекнатите вештини за комуникација или социјални вештини во која било возраст.

- Тешкотии во социјалната интеракција:
 - Има слаб контакт со очите
 - Некогаш изгледа како да не ве слуша, иако реагира на останатите звуци
 - Не реагира на своето име
 - Не е свесно за чувставата на другите
 - Се повлекува во свој свет
 - Не бара помош
 - Избегнува да игра со други деца
 - Тешко ги разбира и ги толкува туѓите мисли, чувства и акции
 - Не може да предвиди што ќе се случи во иднина или што е следно што ќе се случи
 - Не може да го разбере концептот на опасност (на пример колку е опасно ако истрча на улица и најде автомобил)
 - Не може да се вклучи во имагинарна игра и активност
 - Тешко се снаоѓа во нови или непознати ситуации
- Тешкотии во комуникацијата:
 - Избегнува контакт со очите при разговор
 - Ја губи предходно стекнатата способност за зборување
 - Не разговара или ги одлага одговорите
 - Зборува со невообичаен ритам или глас
 - Тешко се започнува разговор
 - Повторува зборови или фрази, а не им го знае значењето
 - Не разбира едноставни прашања или упатства

¹⁷ Jordan, R. (2008). Autism Spectrum Disorders: A Guide for Educators. London.

- Тешкотии во однесувањето:
- Репетативни движења, како нишање на телото и мавтање со раката
- Развива одредени рутина и ритуали и бурно реагира на промените на тие рутина
- Репетативно се движи, се врти, непрекинато ја врти косата, тапка по некое место на себе
- Има тешкотии во доживувањето на времето
- Може подолго време, неподвижно да гледа во еден предмет
- Се воодушевува од детали, без да ја разбира целосната функција на објектот (на пр. се воодушевува од вратничката на автомобилчето, а воопшто не го гледа автомобилчето и не знае за што служи)
- Необично е осетливо на светлина, звук, мирис, и допир, а не е свесно за болка
- Не толерира допир на одредени места од телото
- Необични навики во исхраната (консумирање на одреден вид на храна, некогаш не поднесува два вида на храна во чинијата да се допираат)
- Склоност кон необични работи (како кал, нечистотија)
- Не му пречи нечистотија
- Често се самоповредува (ја удира главата од сид)
- Проблеми со заспивањето, често будење во текот на ноќта и рано будење наутро.(М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 43-44)¹⁸

3.3. Улогата на родителите во препознавање на симптомите

Родителите претставуваат прв и најважен извор на информации за развојот на детето. Тие поминуваат најмногу време со него и имаат можност да ги следат неговите реакции, комуникација и однесување во различни ситуации. Во многу случаи токму родителите први забележуваат дека детето не се развива според очекувањата. Тие можат да забележат отсуство на говор, избегнување контакт со очите, ограничен интерес за игра или необични реакции на стимулите од околината. Дополнително, родителите можат да воочат потешкотии во социјалната интеракција, недостаток на интерес за комуникација со врстниците или присуство на повторувачки однесувања и рутински активности.

Навременото барање стручна помош овозможува брза проценка и започнување соодветни интервенции. Затоа е важно родителите да бидат информирани за раните знаци на аутизмот и да не ги игнорираат евентуалните развојни отстапувања. Нивната активна вклученост во процесот на проценка и интервенција има значајна улога во поддршката на развојот на детето и подобрувањето на неговото секојдневно функционирање. Раното препознавање на симптомите и навремената реакција можат

¹⁸ М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 43-44

значително да придонесат за подобри развојни исходи и поквалитетен живот на детето и неговото семејство. (Siegel, B. (2003). Helping Children with Autism Learn.)¹⁹

3.4. Улогите на воспитувачите и стручните соработници

Воспитувачите имаат исклучително значајна улога во процесот на рано препознавање на аутизмот. Тие секојдневно го набљудуваат детето во групна средина и можат да ги забележат потешкотиите во социјалната интеракција и комуникацијата. Исто така, тие можат да воочат повторувачки модели на однесување, ограничени интереси или потешкотии во прилагодувањето на групните активности и дневните рутина. Стручните соработници во предучилишните установи, како психолозите, педагозите и специјалните едукатори и рехабилитатори, учествуваат во проценката на развојот на детето и даваат насоки за понатамошно постапување. Тие спроведуваат набљудувања, советувања и проценки со цел навремено да се утврдат евентуалните развојни отстапувања и потребите на детето. Покрај тоа, тие обезбедуваат поддршка за воспитувачите и родителите преку препораки за работа и комуникација со детето.

Успешното препознавање на аутизмот бара континуирана соработка меѓу родителите, воспитувачите и стручните лица. Преку редовна размена на информации и заедничко следење на развојот на детето се овозможува навремено упатување кон соодветни стручни служби и обезбедување потребна поддршка. Таквата соработка е клучна за раната интервенција и за создавање услови за оптимален развој на детето. Дополнително, раното препознавање и навремената стручна поддршка можат значително да придонесат за развојот на комуникациските, социјалните и адаптивните вештини кај детето.

3.5. Скрининг и дијагностички инструменти

Во процесот на рано препознавање се користат различни скрининг инструменти кои овозможуваат идентификација на деца со зголемен ризик за аутизам. Овие инструменти најчесто се состојат од прашалници и листи за проценка кои ги пополнуваат родителите или стручните лица врз основа на однесувањето и развојот на детето.

Скринингот претставува почетна постапка за откривање на можни развојни отстапувања. Тој не претставува дијагноза, туку сигнал дека е потребна дополнителна проценка. Неговата главна цел е навремено да ги идентификува децата кај кои постои сомнеж за нарушување од аутистичниот спектар и да овозможи рано упатување кон соодветни стручни служби. Најчесто се спроведува во раното детство, кога можат да се забележат првите знаци на отстапување во комуникацијата, социјалната интеракција и однесувањето. По скринингот следува сеопфатна дијагностичка проценка која ја спроведува мултидисциплинарен тим составен од педијатар, психолог, психијатар, логопед и специјален едукатор и рехабилитатор. Проценката вклучува набљудување на детето, разговор со родителите, анализа на развојната историја и примена на

¹⁹ Siegel, B. (2003). Helping Children with Autism Learn.

стандардизирани дијагностички инструменти. Врз основа на добиените податоци се поставува дијагноза и се планираат соодветни интервенции и форми на поддршка.

Покрај утврдувањето на присуството на аутизам, дијагностичката проценка овозможува да се согледаат и силните страни, потребите и можните придружни тешкотии кај детето. Овие информации се важни за изработка на индивидуализиран план за поддршка и следење на понатамошниот развој. Раната и точна дијагностика е од особено значење бидејќи овозможува навремено започнување на третманот и подобри развојни исходи за детето.(Volkmar, F. R. (2014). Autism and Pervasive Developmental Disorders.)²⁰

4. Интервенции и поддршка по раното препознавање

Раното препознавање на аутизмот претставува само прв чекор во процесот на обезбедување соодветна поддршка за детето. По поставувањето на дијагнозата или идентификувањето на развојниот ризик, неопходно е навремено започнување со интервенции насочени кон развојот на комуникациските, социјалните, когнитивните и адаптивните вештини. Научните истражувања покажуваат дека децата кои се вклучени во програми за рана интервенција постигнуваат значително подобри резултати во однос на развојот и социјалната интеграција.

4.1. Рана интервенција

Раната интервенција претставува организиран систем на услуги и поддршка наменет за деца со развојни потешкотии и нивните семејства. Таа се реализира веднаш по препознавањето на развојните отстапувања и има за цел да ги намали последиците од нарушувањето и да ги поттикне развојните потенцијали на детето.

Во програмите за рана интервенција се вклучени различни стручни лица како психолози, логопеди, специјални едукатори и рехабилитатори, педијатри и социјални работници. Нивната задача е да изработат индивидуализиран план за работа кој ќе биде усогласен со потребите на детето.(Wing, L. (2002). The Autistic Spectrum.)²¹

Раната интервенција придонесува за:

- подобрување на комуникациските способности;
- развој на социјални вештини;
- зголемување на самостојноста;
- намалување на проблематичните облици на однесување;
- подобрување на квалитетот на животот на детето и семејството.

²⁰ Volkmar, F. R. (2014). Autism and Pervasive Developmental Disorders.

²¹ Wing, L. (2002). The Autistic Spectrum.

4.2. Мултидисциплинарен пристап во третманот на аутизмот

Третманот на аутизмот се заснова на мултидисциплинарен пристап во кој учествуваат различни стручни лица со цел да се обезбеди сеопфатна поддршка за детето. Бидејќи аутизмот влијае на повеќе аспекти од развојот, потребна е координирана работа на логопеди, специјални едукатори и рехабилитатори, психолози, педијатри и други професионалци.

Логопедот има важна улога во развојот на комуникациските и јазичните способности. Тој работи на подобрување на разбирањето и употребата на говорот, како и на развојот на алтернативни начини на комуникација кај децата кои имаат ограничен говор.

Специјалниот едукатор и рехабилитатор работи на развојот на когнитивните, социјалните и адаптивните вештини. Неговата цел е да му помогне на детето да стане што е можно посамостојно во секојдневниот живот и успешно да се вклучи во образовната и социјалната средина.

Психологот придонесува во проценката на развојот и однесувањето на детето, како и во обезбедувањето психолошка поддршка за детето и неговото семејство. Тој работи на развој на социјалните вештини, емоционалната регулација и справувањето со различни предизвици во однесувањето.

Во зависност од потребите на детето, во третманот може да бидат вклучени и окупациони терапевти, физиотерапевти и други стручни лица. Успешноста на третманот во голема мера зависи од раното започнување на интервенциите, нивната континуираност и активната соработка помеѓу стручните лица и семејството.

Целта на третманот не е „излекување“ на аутизмот, туку развој на потенцијалите на детето, подобрување на комуникацијата, социјалната интеракција и самостојноста, како и зголемување на квалитетот на животот. (Zager, D. (2013). Autism Spectrum Disorders)²²

4.3. Семејна поддршка и советување

Семејството има централна улога во развојот на детето со аутизам. Родителите се соочуваат со бројни емоционални, психолошки и организациски предизвици по добивањето на дијагнозата.

Затоа е неопходно обезбедување:

- психолошка поддршка;
- едукација за аутизмот;
- советување за воспитни стратегии;
- насоки за поттикнување на развојот во домашни услови;

²² Zager, D. (2013). Autism Spectrum Disorders

- поддршка при остварување на законските права.

Кога родителите активно се вклучени во третманот, резултатите од интервенциите се значително подобри. Тие стануваат активни партнери во развојот и образованието на детето. (Berk, L. E. (2013). Child Development)²³

5. Истражувачки дел

Овој истражувачки проект претставува квалитативна анализа на информации за дете на возраст од 4 години, по име Атанас. Истражувањето е реализирано преку интервјуа со мајката, бабата, дефектологот, логопедот и воспитувачката, со цел да се согледаат првичните симптоми, начинот на нивно препознавање и значењето на раната интервенција.

5.1. Предмет на истражување

Предмет на ова истражување е раното препознавање на симптомите на аутизам кај дете од предучилишна возраст и улогата на семејството и стручните лица во процесот на рана детекција и интервенција.

5.2. Цел на истражувањето

Целта на истражувањето е да се утврдат првичните знаци на аутизам кај детето Атанас, начинот на нивно препознавање од страна на семејството и стручните лица, како и значењето на навремената интервенција врз развојот на детето и неговиот напредок.

5.3. Хипотеза

Главна хипотеза:

Раното препознавање на симптомите на аутизам и навремената стручна интервенциипридонесуваат за подобар развој и социјална адаптација кај детето.

Помошни хипотези:

- Родителите први ги забележуваат развојните отстапувања кај детето.
- Стручните лица имаат значајна улога во процесот на рана детекција.
- Логопедската и дефектолошката поддршка позитивно влијаат врз комуникацијата и однесувањето на детето.
- Инклузијата во воспитно-образовната средина придонесува за подобра социјализација.

²³ Berk, L. E. (2013). Child Development

5.4.Методологија

5.4.1. Метод на истражување

Истражувањето се базира на квалитативна анализа на информации добиени од семејството и стручните лица кои работат со детето.

5.4.2. Техники и инструменти

За собирање на податоците беа користени:

- интервју,
- прашалник,
- набљудување.

5.4.3. Испитаници

Во истражувањето учествуваа:

- мајката на детето,
- бабата,
- дефектолог,
- логопед,
- воспитувачка.

5.4.4. Примерок

Истражувањето е спроведено врз едно дете од машки пол на возраст од 4 години, кај кое се забележани карактеристики поврзани со аутистичен спектар.

5.4.5. Постапка на истражувањето

Интервјуата беа спроведени индивидуално со сите испитаници. Прашањата беа поврзани со раниот развој на детето, комуникацијата, однесувањето, социјалната интеракција и напредокот по вклучувањето на стручна поддршка.

Добиените податоци беа анализирани и споредени со теоретските сознанија за аутизмот и раната интервенција.

5.5. Општи податоци и развоен тек на детето

Атанас е дете на возраст од 4 години, родено на 09.05.2022 кое посетува предучилишни установи. Според информациите добиени од мајката и семејството, бременоста поминала со поголеми компликации- мајката имала плодова вода над нормалата и бактерија (уреоплазма). Во седмиот месец од бременоста бебето се напило

плодова вода и поради тоа мајката била итно задржана на болница каде примала инекции за да се отстрани плодовата вода и побрзо да се породи. Породувањето било со царски рез во систина за подобра безбедност на детето, а детето било родено со нормална телесна тежина и добар општ здравствен статус по прегледување на срцето и главата.

Во првите месеци од развојот не биле забележани поголеми отстапувања, единствено тоа што бебето главата ја држело само налево. Меѓутоа, со текот на времето родителите започнале да забележуваат одредени потешкотии во комуникацијата и социјалната интеракција. Детето ретко воспоставувало контакт со очи, покажувало ограничен интерес за игра со врсници и имало претерано доцнење во говорниот развој.

Во однесувањето биле забележани повторувачки активности и зборови и чувствителност на одредени звуци и допир. Атанас не реагирал на неговото име, најчесто сакал самостојна игра и потешко прифаќал промени во секојдневните активности. Тој на неговата 4 годишна возраст сеуште носи пелени и не зборува.

Прв пат родителите на Атанас побарале стручна помош по неговата прва година на 06.11.2023 во систина од педијатар, а потоа на 15.11.2023 и од невролог. По консултација со стручни лица, детето било вклучено во логопедски и дефектолошки третмани, при што постепено се забележува напредок во комуникацијата и социјализацијата. Дефинитивното утврдување дека Атанас има аутизам било на неговата 3 годишна возраст на 13.03.2026 во државна болница во Скопје од страна на стручни лица.

5.5.1. Субјективен опис на однесувањето и развојот на детето од страна на мајката

Атанас е дете кое испушта чудни звуци наместо да зборува. Често вика ју,ју,ју-ја,ја,ја. Како помал често гледаше телевизија. Сеуште носи пелени на неговата три годишна возраст. Кога чувствува дека памперсот е искористен често пробува да го слече, но не знае како. Моментално користи витамини препорачани од невролог. Прв пат се утврди дека атанас има аутизам на 13 март 2026 година во Скопје. Атанас самиот си ги собира играчките или смоките што ги истурил додека ги јадел. Доста знае да биде хиперактивен и може да се сличи да се самоповредува.

5.5.2. Субјективен опис на однесувањето и развојот на детето од страна на бабата

Атанас е дете кое воопшто не слуша и не почитува наредби. Тој од сите нас домашните (бидејќи живееме заедно) најмногу го слуша неговиот дедо затоа што не му дозволува се и го кара, а останатите често не го слуша. Атанас доколку го искараш знае да те разбере, но многу ретко. Неговите играчки кој му се нови ска да ги отвори но пак да му бидат во кутијата и така да стојат. Доколку игра со нив повторно ги враќа назад во кутијата и не сака да се поместуваат. Доколку друго дете сака да му ја земе играчката со која Атанас си игра, знае да биде хиперактивен и да не ја дава играчката. Исто така Атанас сака да игра со чаша полна со вода. Рацете ги реди во чашата и зема стапче да

ја меша водата. Често пати, претежно шишина и кутии ги зема - ги реди на под, легнува до нив и ги набљудува. Сака да се качува по скали и да слегува повеќе пати. Сака да лиже предмети, врати, маси и слично. Кога ќе види река или езеро сака да скокне во водата и не се плаши од ризикот. Нема страв од височина и често пати се повредува поради тоа или да истрча во река бидејќи е непредвидлив. Има потешкотии во спиењето, но не често и бидејќи тогаш е хиперактивен му даваме мелатонин по потреба. Атанас до втората година јадееше секаков вид на храна, но сега ја бира храната и јаде само тоа што го сака тој. Најчесто јаде смоки и бисквити, а од течности пие само сок и многу ретко вода. Млечни производи не поднесува и сака да јаде кашички за бебе.

5.6.Анализа на добиените податоци

5.6.1. Анализа на интервју со мајката

Врз основа на спроведеното интервју со мајката, добиени се значајни податоци за раниот развој на детето и за првичните знаци кои упатувале на развојни отстапувања. Според нејзините искази, првите симптоми биле забележани околу втората година од животот, период кој претставува значајна развојна фаза во која вообичаено се очекува интензивен напредок во говорно-јазичниот, социјалниот и комуникацискиот развој. Мајката навела дека детето ретко воспоставувало директен контакт со очи, што претставувало една од првите карактеристики кои го разликувале од неговите врсници. Недостатокот на очен контакт бил забележлив како во комуникацијата со членовите на семејството, така и при интеракција со други лица од непосредната околина. Ова однесување укажувало на потешкотии во развојот на социјалната интеракција и воспоставувањето на реципрочни односи со другите. Во однос на говорно-јазичниот развој, мајката истакнала дека детето покажувало значително доцнење во развојот на говорот. Во периодот кога повеќето деца започнуваат да користат зборови и едноставни реченици за изразување на своите потреби и желби, кај него не била забележана употреба на вербална комуникација. Дополнително, детето ретко иницирало комуникација и не покажувало интерес за споделување на искуства, емоции или активности со другите лица. Мајката исто така нагласи дека детето имало потешкотии во разбирањето и користењето на невербалните форми на комуникација, како што се покажување со прст, користење гестови или следење на погледот на соговорникот. Во текот на раното детство, детето често преферирало самостојна игра наместо вклучување во заеднички активности со врсници или членови на семејството. Според мајката, неговата игра најчесто била ограничена на одредени предмети или активности, без значајна вклученост на имагинативна или симболичка игра. Наместо социјална интеракција, детето покажувало поголем интерес за индивидуални активности и рутина кои му биле познати и предвидливи. Дополнително, биле забележани повторувачки и стереотипни облици на однесување. Мајката опиша дека детето често изведувало повторувачки движења, како мавтање со рацете, вртење околу сопствената оска или повторување на одредени активности и зборови во подолг временски период. Ваквите однесувања се јавувале особено во ситуации на возбуда, стрес или кога детето било преокупирано со одреден интерес. Покрај тоа, промените во секојдневните активности често предизвикувале вознемиреност или отпор. Исто така изјави дека Атанас сеуште носи пелени на негова 4 годишна возраст, не јаде сам и не користи јасни зборови.

5.6.2. Анализа на интервју со бабата

Според исказот на бабата, уште во раното детство биле забележливи разлики во однесувањето на детето во споредба со неговите врсници. Таа истакнала дека детето се разликувало во начинот на игра и комуникација, покажувајќи намален интерес за воспоставување социјални контакти и заеднички активности со другите. Бабата навела дека детето често избегнувало интеракција со луѓе, претпочитајќи самостојна игра и ограничено вклучување во активности. Забележала дека реагирало чувствително на силни звуци и други интензивни сензорни дразби, при што покажувало знаци на вознемиреност или непријатност. Дополнително, кога Атанас сакал да побара нешто, тоа го изразува со влечење на рака. Кога доаѓале гости во домот ги влечел надвор бијдејќи не сакал гужва. Често се загледувал во еден предмет, гледајќи го повеќе минути.

5.6.3. Анализа на интервју со дефектологот

Дефектологот забележал потешкотии во социјалната интеракција, контакт со очи, вниманието и комуникацијата, доста хиперактивен и не извршувал одредени налози. Според стручната проценка, кај детето се присутни карактеристики типични за аутистичен спектар. Исто така било нагласено дека редовните третмани придонесуваат за постепен напредок. Детето со редовни третмани ќе покажува позитивен одговор на применетите интервенции, при што се забележува постепено подобрување во воспоставувањето контакт, следењето инструкции и вклучувањето во структурирани активности. Се препорачува континуитет во третманите и понатамошна стручна поддршка со цел поттикнување на развојот и зајакнување на функционалните вештини.

5.6.4. Анализа на интервју со логопедот

Логопедот истакнал дека кај детето постојат потешкотии во разбирањето на вербалната комуникација и нема говор. Со текот на третманите се забележува подобрување во изразувањето и комуникацијата. Детето постепено ќе почне да изговара зборови и ќе го збогатува својот речник, покажува подобро разбирање на едноставни инструкции и сè почесто воспоставува соодветна комуникација со лицата од непосредната околина. Забележлив е напредок и водржувањето на вниманието за време на логопедските активности, како и во користењето на вербални и невербални средства за изразување на потребите и желбите. Се препорачува продолжување со редовните логопедски третмани со цел понатамошно унапредување на комуникациските и јазичните вештини.

5.6.5. Анализа на интервју со воспитувачката

Воспитувачката забележала дека детето избегнува контакт со очи, не реагира на неговото име, има потешкотии при групни активности и комуникација со врсниците. Сепак, со поддршка и адаптација на активностите, детето постепено покажува подобра вклученост во групата. Во секојдневните активности е потребно дополнително насочување и поттикнување за воспоставување и одржување на социјални интеракции со другите деца. Детето полесно функционира во структурирана средина со јасно

поставени правила и рутини, а во ситуации кои бараат поголема социјална ангажираност често има потреба од поддршка од возрасно лице. Се препорачува континуирана соработка помеѓу воспитувачите, стручните лица и семејството со цел обезбедување соодветни услови за негово учество во воспитно-образовниот процес.

5.6.6. Анализа на стручна документација

Врз основа на достапната медицинска документација, може да се согледа дека Атанас бил континуирано слден од повеќе здравствени установи и специјалисти уште од најрана возраст.

Според лекарски извештај од 06.11.2023 година издаден во Ацибадем Систина, од Одделот за неврологија, биле забележани отстапувања во говорно-јазичниот и психомоторниот развој. Во извештајот е наведено дека детето има ограничен развој на говорот и потешкотии во комуникацијата, поради што биле препорачани дополнителни специјалистички прегледи и следење на развојот.

Во следен извештај од 15.11.2023 година, исто така издаден во Ацибадем Систина, повторно се констатира развојно доцнење и се наведува дијагноза поврзана со нарушување во очекуваниот физиолошки развој. Препорачани биле лабораториски испитувања, логопедски третман и редовни контроли.

На 24.06.2024 година во ЈЗУ Здравствен дом – Скопје, Завод за ментално здравје на деца и младинци, од страна на детски психијатар е поставена дијагноза F80.0 – специфично нарушување на артикулацијата, при што се препорачуваат логопедски третмани, ЕЕГ испитување и контролни прегледи.

Во извештај од декември 2024 година, издаден во Општа болница со проширена дејност – Прилеп, се наведува дијагноза F80, а забележани се потешкотии во вербалната комуникација, ограничен контакт со околината и присуство на одредени стереотипни однесувања. Повторно се препорачуваат логопедски и дефектолошки третмани.

Во документацијата од 05.05.2025 година, издадена во ЈЗУ Здравствен дом – Скопје, Завод за ментално здравје на деца и младинци, се опишуваат потешкотии во социјалната интеракција, комуникацијата и однесувањето. Наведено е дека детето покажува ограничен интерес за врстници, присутни се повторувачки активности и потреба од континуирана стручна поддршка.

Во извештај од 11.07.2025 година во истата установа е поставена дијагноза F80.1, а се наведува и дека е направено тестирање со повеќе развојни инструменти и проценки. Препорачани се редовни контроли и продолжување на третманите.

Во најновата документација од 13.03.2026 година, по извршените проценки и следење на развојот, е поставена дијагноза F84.0 – детски аутизам. Во извештајот се наведува дека се присутни потешкотии во комуникацијата, социјалната интеракција и адаптивното функционирање, поради што се препорачува продолжување на логопедскиот и дефектолошкиот третман.

Од анализата на документацијата може да се забележи дека процесот на дијагностицирање се одвивал постепено. Првично биле забележани говорно-јазични и развојни потешкотии, а преку континуирано следење од страна на специјалисти во Ацибадем Систина, Заводот за ментално здравје на деца и младинци во Скопје и Општата болница во Прилеп, била поставена конечната дијагноза F84.0 – детски аутизам. Ова укажува на значењето на раното препознавање на симптомите и навременото вклучување на стручна поддршка.

5.7. Прилози

ТАБЕЛА 1. ИНТЕРВЈУ СО МАЈКАТА

Бр.	Прашање	Одговор
1	Кога е роден Атанас?	Атанас е роден на 05.05.2022 година.
2	Како помина бременоста и дали имаше компликации?	Имав компликации, повеќе плодова вода и бактерија (уреоплазма). Во седми месец бебето се напи плодова вода и бев задржана во болница.
3	Дали породувањето беше природно или со царски рез?	Породувањето беше со царски рез во Систина.
4	Дали имаше здравствени проблеми веднаш по раѓањето?	Немаше здравствени проблеми ниту кај мене ниту кај бебето.
5	Кога почна да ја држи главата?	На околу три месеци.
6	Кога почна да седи самостојно?	На 6 месеци, а на 1 година и 3 месеци се исправи на нозе.
7	Кога почна да оди?	На една година.
8	Кога почна да изговара зборови?	На 8 месеци ги изговараше зборовите „мама“, „бу“ и „баба мими“, но подоцна ги заборави.
9	Дали развојот во првата година изгледаше нормален?	Да, изгледаше нормален.
10	Дали реагира кога го повикувате по име?	Многу ретко.
11	Дали воспоставува контакт со очи?	Зависи од ситуацијата.
12	Дали користи зборови или гестови за потребите?	Не користи ниту зборови ниту гестови.
13	Дали покажува со прст кога сака нешто?	Да, влече за рака и потоа покажува.
14	Дали разбира едноставни инструкции?	Не секогаш.
15	Како реагира кога ќе види други деца?	Понекогаш се радува, но често не ги регистрира.
16	Дали сака да игра со други деца?	Претпочита да игра сам.
17	Како реагира на непознати	Нема посебни реакции.

	луѓе?	
18	Дали покажува емоции?	Повеќе покажува радост.
19	Дали има омилен играчки или активности?	Сака автомобили, топки, трчање, скокање, музика и тапани.
20	Дали повторува одредени движења?	Мафта со рацете и аплаудира.
21	Дали има потреба од рутина?	Нема.
22	Како реагира на промени во секојдневието?	Се лути, скока и плаче.
23	Дали е чувствителен на звуци, светлина или допир?	Не сака допир и гласни звуци.
24	Дали има необични реакции на звуци?	Нема.
25	Дали изгубил претходно стекнати вештини?	Да, заборави зборови и играше со помал број играчки.
26	Кога првпат забележавте промени?	По првата година, а поизразени на втората година.
27	Кога првпат побаравте стручна помош?	Во ноември 2023 година кај педијатар, невролог и дефектолог.
28	Како реагира на терапиите?	На почеток се плашеше, а подоцна беше посмирен.
29	Дали забележувате напредок?	Да, има напредок.
30	Кој е најголемиот предизвик?	Бега надвор, не сака да се врати дома и е многу хиперактивен.

ТАБЕЛА 2. ИНТЕРВЈУ СО БАБАТА

Бр.	Прашање	Одговор
1	Колку често го чувате Атанас?	Многу често во последната година.
2	Какво е неговото однесување кога е со вас?	Мирен е и послушен.
3	Како комуницира со вас?	Со влечење за рака.
4	Дали реагира кога ќе го повикате по име?	Понекогаш.
5	Како се однесува кога сака нешто?	Влече за рака, а ако не е разбран плаче и скока.
6	Дали сака да игра со вас?	Да.
7	Кои активности најмногу ги сака?	Трчање, игра со вода, автомобили и музика.
8	Дали забележувате повторувачки навики?	Мафтање со раце и удирање по нозете и главата.
9	Како реагира кога нешто ќе му се забрани?	Плаче, каса, се влече по земја и се самоповредува.
10	Како реагира кога доаѓаат гости?	Не се вознемирува од мал број гости, но повеќе гости ги влече кон излезот.
11	Дали забележувате промени во однесувањето?	Да, има сè повеќе промени.

12	Кога првпат забележавте необично однесување?	Пред првата година.
13	Дали избегнува контакт со очи?	Да.
14	Дали сака физички контакт?	Понекогаш бара прегратки.
15	Како реагира на нови ситуации?	Тешко ги прифаќа промените и покажува приврзаност кон познатата средина.

ТАБЕЛА 3. ИНТЕРВЈУ СО ДЕФЕКТОЛОГОТ

Бр.	Прашање	Одговор
1	Кога започна третманот за Атанас?	На 19.02.2025 година.
2	Кое е моменталното функционално ниво на Атанас?	Подобрен контакт со очи, повремена реакција на име и покажување со рака. Најчесто игра сам.
3	Какво е нивото на говор?	Сè уште нема развиен говор.
4	Кои се најчестите предизвикувачки однесувања?	Тантруми, особено кога нешто му е ограничено.
5	Каков напредок е постигнат?	Подобрено внимание, интерес, имитација и перцепција на себе.
6	Како родителите можат да помогнат дома?	Да ги повторуваат препорачаните активности по третманите.
7	Дали има потреба од дополнителни терапии?	Да, логопедски третмани и неурофидбек.

ТАБЕЛА 4. ИНТЕРВЈУ СО ЛОГОПЕДОТ

Бр.	Прашање	Одговор
1	Кога беше упатен Атанас на логопедски третман?	Неодамна поради тешкотии во комуникацијата и отсуство на говор.
2	Каква беше комуникацијата при првата средба?	Немаше очен контакт, многу плачеше и потешко следеше инструкции.
3	Кои се најизразените потешкотии?	Потешкотии во експресивниот говор, социјалната комуникација и заедничкото внимание и не дозволува допир.
4	Како реагира на логопедските активности?	Покажува мал интерес, а вниманието е краткотрајно.
5	Дали разбира едноставни инструкции?	Понекогаш, особено со визуелна поддршка.
6	Кои цели се поставени во третманот?	Развој на функционална комуникација, разбирање и социјална интеракција и третман за вежбање на јазикот.
7	Кои методи ги користите?	Игра, визуелни поттикнувачи, моделирање на говор и комуникациски активности.

8	Каква е соработката со родителите?	Родителите активно учествуваат и добиваат насоки за работа дома.
9	Дали се забележува напредок?	Промените се мали, но се забележува постепено прифаќање на активностите.
10	Кои се препораките за понатамошна работа?	Редовни третмани, работа дома и соработка меѓу сите стручни лица.

ТАБЕЛА 5. ИНТЕРВЈУ СО ВОСПИТУВАЧКАТА

Бр.	Прашање	Одговор
1	Колку долго Атанас посетува градинка?	Посетува градинка одреден период и е дел од воспитната група.
2	Како се адаптираше на градинката?	Адаптацијата беше побавна, но постепено се чувствува посигурно.
3	Како комуницира со воспитувачите?	Најчесто преку гестови и покажување.
4	Како комуницира со другите деца?	Повеќе игра самостојно и ретко иницира контакт.
5	Дали ги следи групните активности?	Многу ретко и зависи од интересот и поддршката.
6	Како реагира на промени во дневната рутина?	Понекогаш покажува несигурност и вознемиреност.
7	Кои се неговите силни страни?	Добро реагира на визуелни материјали и има добра меморија за интересни содржини.
8	Дали има потреба од дополнителна поддршка?	Да, потребна е индивидуализирана поддршка.
9	Како соработувате со семејството?	Редовно разменуваме информации за напредокот и потребите на детето.
10	Кои промени би сакале да ги видите во иднина?	Поголема самостојност, подобра комуникација со врсниците, поголемо учество во активностите и одвивање од памперс.

ТАБЕЛА 6. СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА НА ПОЧЕТНАТА И МОМЕНТАЛНАТА СОСТОЈБА НА АТАНАС СПОРЕД СТРУЧНИТЕ ЛИЦА

Стручно лице	Почетна состојба	Моментална состојба	Забележан напредок
Дефектолог	Не разбира каде доаѓа	Разбира каде доаѓа	Постигната е подобра ориентација и разбирање на средината
Дефектолог	Воопшто не играше со деца	Игра со деца	Зголемена социјална интеракција
Дефектолог	Немаше интерес за играчките	Появува интерес за играчките	Развиен интерес за игра и истражување

Дефектолог	Нема реакција кога ќе му се одземе нешто	Реагира со зборот „не“ и бара назад	Развивање на комуникациски реакции и изразување
Дефектолог	Не разбира налози (седни, стани)	Разбира налози	Подобра рецептивна комуникација
Дефектолог	Не седнуваше и не учествуваше во графомоторика	Црта линии и кругови	Подобрување на графомоторни вештини
Дефектолог	Не се препознава пред огледало	Се препознава со минимални промени	Развивање на свесност за себе
Дефектолог	АБА терапија не функционираше	АБА терапија функционира	Подобра адаптација на терапевтски активности
Логопед	Нема контакт со очи	Се појавува контакт со очи	Подобрување на визуелна комуникација
Логопед	Не дозволува допир	Дозволува допир	Намалена сензорна хиперсензитивност
Логопед	Не покажува делови од тело	Покажува нос	Развивање на разбирање и идентификација на делови од тело
Логопед	Не дозволува допир со инструменти	Понекогаш дозволува	Зголемена толеранција на терапевтски активности
Логопед	Нема свесност за предмети	Появува свесност	Подобро разбирање на функцијата на предметите
Логопед	Не реагира со смеење	Се смее во смешни ситуации	Развивање на емоционална реакција
Воспитувачка	Не извршуваше налози	Понекогаш извршува	Делумно подобрување во следење инструкции
Воспитувачка	Не игра со деца и не дели играчки	Игра и дели играчки	Подобра социјализација
Воспитувачка	Не стои во редица, се врти со грб	Стои правилно во редица	Подобрување на групно однесување

5.8. Дискусија

Резултатите добиени од интервјуата со мајката, бабата, дефектологот, логопедот и воспитувачката укажуваат на комплексен развоен профил кај детето Атанас, со изразени тешкотии во областа на комуникацијата, социјалната интеракција, говорно-јазичниот развој и сензорната обработка.

Од податоците на мајката се забележува дека во раниот развој постоеле одредени одложувања и регресија во говорот, како и отсуство на функционална комуникација преку зборови и гестови. Исто така, се присутни однесувања како хиперактивност,

повторувачки движења и чувствителност на промени во средината. Мајката истакнува дека детето претпочита самостојна игра и има ограничена социјална интеракција.

Информациите од бабата дополнително ја потврдуваат сликата за ограничена комуникација, главно преку влечење за рака, како и тешкотии при толкување на желбите и потребите на детето. Се забележуваат и саморегулаторни и бихевиорални тешкотии, особено при поставување граници или забрани.

Од страна на стручните лица се забележува значителен напредок во однос на почетната состојба. Дефектологот укажува на подобрување во разбирањето на налози, појава на интерес за играчки, подобрена социјална интеракција и развој на основни когнитивни и графомоторни вештини. Исто така, се забележува поголема реактивност во комуникациски ситуации и подобра адаптација на терапевтски активности.

Логопедот наведува дека иако говорот сè уште не е развиен, постои позитивен тренд во насока на зголемување на контактот со очи, подобрување на сензорната толеранција (допир), како и појава на свесност за предмети и емоционални реакции. Овие промени укажуваат на постепено отворање на каналите за комуникација.

Воспитувачката истакнува дека детето има подобрување во групната интеракција, делумно следење на налози и поголема адаптација во воспитно-образовната средина, иако сè уште постои потреба од индивидуализирана поддршка.

Споредбената анализа (пред и после интервенција) покажува јасен напредок во повеќе домени: подобра социјализација, зголемено разбирање на инструкции, појава на функционални реакции (зборот „не“, покажување, реагирање на име) и подобрување во играта и вниманието. И покрај тоа, комуникацијата останува ограничена и бара континуирана терапевтска поддршка.

Заклучок

Аутизмот претставува комплексно невроразвојно нарушување кое значително влијае врз социјалниот, комуникацискиот и емоционалниот развој на детето. Иако симптомите и нивната изразеност се разликуваат од дете до дете, заедничка карактеристика е присуството на потешкотии во воспоставувањето социјални односи, комуникацијата и флексибилноста на однесувањето. Раното препознавање на аутизмот претставува еден од најзначајните предуслови за успешна интервенција и поддршка. Современите научни сознанија укажуваат дека првите симптоми можат да се забележат уште во првите години од животот. Затоа е неопходно родителите, воспитувачите и стручните лица да бидат информирани за раните знаци кои можат да укажуваат на постоење на аутистичен спектар на нарушувања.

Во трудот беше истакнато дека навременото препознавање на симптомите овозможува рана дијагностика и започнување на соодветни интервенции. Раната интервенција има значајно влијание врз развојот на комуникациските способности, социјалните вештини, самостојноста и целокупното функционирање на детето. Колку порано се започне со третманот, толку се поголеми можностите за постигнување позитивни резултати.

Посебна улога во процесот на препознавање и поддршка има семејството. Родителите најчесто први ги забележуваат развојните отстапувања и иницираат барање стручна помош. Од друга страна, воспитувачите и стручните соработници имаат можност да го следат однесувањето на детето во групна средина и да ги забележат потешкотиите кои можеби не се видливи во домашни услови.

Исто така, во трудот беше нагласена важноста на мултидисциплинарниот пристап во проценката и поддршката на децата со аутизам. Соработката меѓу педијатрите, психолозите, логопедите, специјалните едукатори и рехабилитатори и воспитувачите овозможува поцелосно согледување на потребите на детето и планирање на соодветни интервенции.

Може да се заклучи дека раното препознавање на аутизмот кај децата од предучилишна возраст е од исклучително значење за нивниот понатамошен развој и квалитет на живот. Подигнувањето на свеста за раните симптоми, унапредувањето на системите за скрининг и проценка, како и обезбедувањето достапни и квалитетни услуги за рана интервенција претставуваат основни предуслови за успешна поддршка на децата со аутизам и нивните семејства.

Спроведеното квалитативно истражување претставуваше практична потврда на теоретските сознанија обработени во трудот. Анализата на процесот на рано препознавање на аутизмот укажа дека навременото забележување на раните развојни индикатори има суштинско значење за понатамошниот тек на проценката, интервенцијата и поддршката. Истражувањето ја нагласи важноста на континуираното следење на детскиот развој, информираноста на родителите и стручната подготвеност на професионалците кои работат со деца од предучилишна возраст. Наодите дополнително ја потврдуваат потребата од навремена реакција при појава на развојни отстапувања со цел создавање подобри услови за развој и социјална интеграција на детето.

Користена литература

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). Washington, DC.
- Attwood, T. (2007). The Complete Guide to Asperger's Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers
- Berk, L. E. (2013). Child Development.
- Catherine Lord, Michael Rutter et al. (2020). Autism Spectrum Disorder. The Lancet.
- Frith, U. (2003). Autism: Explaining the Enigma. Oxford: Blackwell Publishing
- Jordan, R. (2008). Autism Spectrum Disorders: A Guide for Educators. London.
- Siegel, B. (2003). Helping Children with Autism Learn.
- Volkmar, F. R. (2014). Autism and Pervasive Developmental Disorders.
- Wing, L. (2002). The Autistic Spectrum.
- Zager, D. (2013). Autism Spectrum Disorders
- Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр18
- Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр19
- Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр20
- Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр140-141
- Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр142
- Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр 150-151
- Владимир Е. Трајковски, Аутизам стр155
- Кировска, М. Развојни нарушувања кај деца
- М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 40
- М.Ристевска, Инклузивна педагогија стр.43
- М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 43-44
- М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр.46-47
- М. Ристевска, Инклузивна педагогија стр 49.